

OCCLUSÃO RETINIANA — ARTÉRIA = AVC OCULAR

OCCLUSÃO ARTERIAL vs VENOSA

Aspecto	OACR (arterial)	OVCR (venosa)
Perda visual	Súbita, profunda, indolor (conta dedos/PL)	Súbita ou subaguda, variável
Fundo de olho	Retina pálida edemaciada + mácula em 'cereja'	Hemorragias em chama difusas + veias tortuosas/dilatadas
Mecanismo	Embolia (carótida, cardíaca) ou trombose	Trombose venosa (estase, hipercoagulabilidade)
Equivalente	É um AVC — investigar como AVC ocular	Estase venosa, similar a TVP
Fatores de risco	Aterosclerose, FA, estenose carotídea, arterite temporal	HAS, DM, glaucoma, hiperviscosidade, trombofilia
Prognóstico visual	Reservado (janela <90-240 min para retina)	Variável — depende de isquemia/edema macular

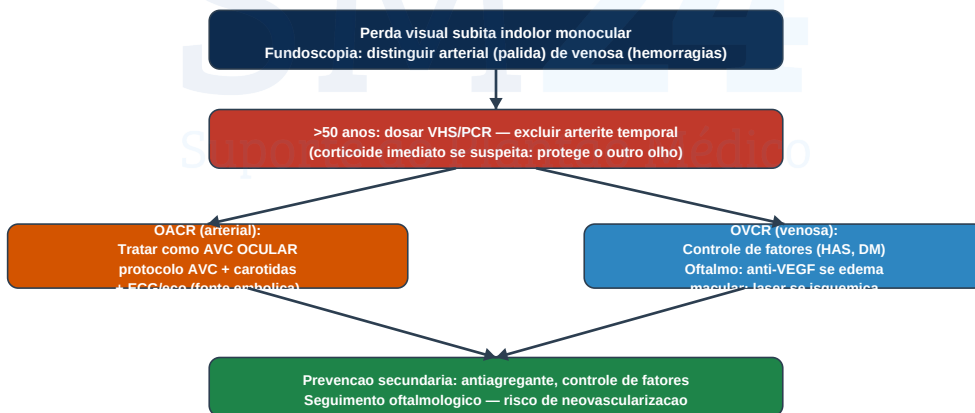
OACR — AVC OCULAR — EMERGÊNCIA TEMPO-DEPENDENTE

OCCLUSÃO DE ARTÉRIA CENTRAL DA RETINA = AVC

- Perda visual súbita, indolor, profunda em um olho — equivalente a um AVC
- Fundo: retina pálida/edemaciada + mácula em vermelho-cereja (cherry-red spot)
- Janela de isquemia retiniana: ~90-240 min para sobrevida neuronal (curta!)
- INVESTIGAR COMO AVC: encaminhar a centro com protocolo de AVC (neuroimagem, carótidas, ECG/eco)
- Excluir ARTERITE TEMPORAL em >50 anos: VHS/PCR — corticoide imediato se suspeita (protege o outro olho)
- Manobras agudas (massagem ocular, reduzir PIO) têm eficácia limitada; foco na causa e prevenção secundária

ABORDAGEM DA PERDA VISUAL SÚBITA VASCULAR

OCCLUSÃO RETINIANA — TRATAR COMO AVC



OVCR — CLASSIFICAÇÃO E COMPLICAÇÕES

Tipo / Complicação	Características	Conduta
OVCR não isquêmica	Perda visual leve-moderada, melhor prognóstico	Observação + controle de fatores
OVCR isquêmica	Perda visual grave, áreas de não perfusão	Risco alto de neovascularização — laser
Edema macular	Principal causa de baixa visão na OVCR	Anti-VEGF intravítreo (ranibizumabe, aflibercepte)
Glaucoma neovascular	Neovasos na íris → glaucoma (90 dias - 'glaucoma dos 100 dias')	Panfotocoagulação + controle de PIO
Oclusão de ramo (ORVR)	Setorial, segue trajeto de uma veia	Anti-VEGF se edema macular; laser focal

INVESTIGAÇÃO E DIFERENCIAL

Investigação da OACR

- Doppler de carótidas: estenose como fonte embólica (avaliar endarterectomia)
- ECG e Holter: fibrilação atrial
- Ecocardiograma: trombo, vegetação, forame oval
- VHS/PCR: arterite temporal (>50 anos) — urgente
- Perfil de risco vascular: glicemia, lipídios, PA
- Encaminhar a protocolo de AVC: risco de AVC cerebral subsequente

Diferencial e Prevenção

- Arterite temporal: cefaleia, claudicação de mandíbula, VHS alto — corticoide imediato
- Neuropatia óptica isquêmica: déficit pupilar aferente, edema de disco
- Descolamento de retina: cortina, floaters, fofopsias
- Prevenção: antiagregante, estatina, controle de PA/DM, cessar tabagismo
- OACR tem mesmo risco vascular que AVC — manejo da prevenção secundária
- Seguimento oftalmológico para neovascularização

PONTOS-CHAVE NO PS

PERDA VISUAL VASCULAR

- ☐ OACR é um AVC ocular — investigar e manejar como AVC (neuroimagem, carótidas, fonte embólica)
- ☐ Em >50 anos com OACR/perda visual: dosar VHS/PCR e tratar arterite temporal empiricamente se suspeita
- ☐ Distinção fundoscópica: arterial (retina pálida + mácula cereja) vs venosa (hemorragias em chama)
- ☐ OVCR: principal causa de baixa visão é o edema macular — anti-VEGF intravítreo
- ☐ OVCR isquêmica: risco de glaucoma neovascular ('glaucoma dos 100 dias') — laser
- ☐ Prevenção secundária vascular: antiagregante, estatina, controle de fatores de risco

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente de 68 anos com perda visual súbita, indolor e profunda no olho direito. Fundo de olho: retina pálida com mácula em vermelho-cereja. Qual é o diagnóstico e a conduta?

- A) Oclusão de veia central da retina — anti-VEGF
- B) Oclusão de artéria central da retina (AVC ocular) — investigar e manejar como AVC + dosar VHS/PCR (arterite temporal)
- C) Descolamento de retina — vitrectomia
- D) Glaucoma agudo — pilocarpina
- E) Catarata — cirurgia eletiva

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

No fundo de olho, a presença de hemorragias em chama difusas, veias tortuosas e dilatadas sugere:

- A) Oclusão de artéria central da retina
- B) Oclusão de veia central da retina (OVCR)
- C) Arterite temporal
- D) Descolamento de retina regmatogênico
- E) Endoftalmite

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a oclusão de artéria central da retina deve ser investigada como um AVC?

- A) Porque sempre evolui para AVC cerebral em 24h
- B) Porque compartilha os mesmos mecanismos (embolia/aterosclerose) e fatores de risco, indicando alto risco de AVC cerebral e necessidade de prevenção secundária
- C) Porque a retina faz parte do tronco cerebral
- D) Porque é causada por trombose venosa
- E) Porque o tratamento é a trombólise sempre

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é a principal causa de baixa acuidade visual na oclusão de veia central da retina?

- A) Descolamento de retina
- B) Edema macular (tratado com anti-VEGF intravítreo)
- C) Catarata secundária
- D) Atrofia óptica
- E) Hemorragia vítrea maciça

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em paciente >50 anos com perda visual súbita por oclusão arterial, qual exame NÃO pode faltar para excluir uma causa tratável que ameaça o outro olho?

- A) Tomografia de crânio
- B) VHS e PCR (para arterite de células gigantes / temporal) — corticoide imediato se suspeita
- C) Campimetria
- D) Tonometria
- E) Eletroretinograma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

OACR (oclusão de artéria central da retina): perda visual súbita, indolor, profunda + retina pálida com mácula em vermelho-cereja. É um AVC ocular — investigar fonte embólica (carótidas, ECG/eco) e manejar prevenção secundária como AVC. Em >50 anos: dosar VHS/PCR para excluir arterite temporal.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

OVCR (oclusão de veia central da retina): hemorragias retinianas em chama difusas + veias tortuosas e dilatadas + edema. Mecanismo de estase/trombose venosa. Diferente da OACR (retina pálida + mácula cereja). Fatores: HAS, DM, glaucoma, hiperviscosidade.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A OACR compartilha os mesmos mecanismos (embolia de carótida/coração, aterosclerose) e fatores de risco do AVC cerebral. O paciente tem alto risco de AVC subsequente. Por isso deve ser investigado e manejado como AVC (neuroimagem, carótidas, fonte cardíaca) com prevenção secundária.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O edema macular é a principal causa de baixa acuidade visual na OVCR. O tratamento de primeira linha é o anti-VEGF intravítreo (ranibizumabe, aflibercepte, bevacizumabe), que reduz o edema e melhora a visão. Corticoide intravítreo é alternativa.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Em >50 anos com oclusão arterial/perda visual, dosar VHS e PCR para excluir arterite de células gigantes (temporal) — causa tratável que ameaça o olho contralateral. Se houver suspeita (cefaleia, claudicação de mandíbula, VHS muito alto): corticoide em altas doses IMEDIATAMENTE, sem aguardar a biópsia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico